Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4° andar - Bairro: Exposição - CEP: 95080-155 - Fone: (54) 996790955 - Email: frcaxsul5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5011841-41.2025.8.21.0010/RS

AUTOR: IRENE GAUER

RÉU: UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos etc.

IRENE GAUER, parte já qualificada nos autos, ajuizou a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER** em face de **UNIMED SERRA GAÚCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA**, pessoa jurídica também qualificada.

Narrou, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde mantido junto à ré desde 01 de junho de 1987. Relatou ter sido diagnosticada com fibrose pulmonar secundária à Esclerodermia (CID 10: J84.1), uma doença pulmonar que descreveu como grave, de caráter evolutivo e progressivo. Mencionou que, em razão da idade avançada e da esclerodermia, não pode ser incluída em lista de transplante pulmonar. Afirmou ter se submetido a tratamentos prévios com prednisona e azatioprina, sem, contudo, obter o controle da progressão da enfermidade, com perda significativa da função pulmonar. Sustentou que, para a preservação de sua função pulmonar e para evitar a rápida progressão da doença, seu médico assistente, Dr. Adalberto Sperb Rubin, prescreveu tratamento de uso contínuo, imediato e por tempo indeterminado com o medicamento NINTEDANIBE (OFEV) 150mg, a ser administrado a cada 12 horas. Alegou que, ao submeter o pedido de cobertura à ré, este foi negado em 04 de março de 2025, sob a justificativa de se tratar de medicamento de uso oral e domiciliar, com indicação *off-label* para o seu quadro clínico, e que a cobertura, conforme diretriz da ANS, seria apenas para tratamento de câncer de pulmão. Defendeu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade da negativa e o dever de cobertura da operadora, uma vez que a doença possui cobertura contratual e não cabe à ré limitar o tratamento prescrito pelo médico. Ao final, pugnou pela concessão de tutela de urgência para determinar o imediato fornecimento do fármaco e, no mérito, a confirmação da tutela para condenar a ré à obrigação de fazer, consistente no custeio do tratamento, além dos consectários de sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$13.460,00. Juntou documentos.

Recebida a inicial, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça, mas indeferida a tutela de urgência (Evento 5). Da decisão, a parte autora opôs embargos de declaração (Evento 7), os quais foram rejeitados (Evento 10). Após, interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negativo provimento (processo 5067464-72.2025.8.21.7000/TJRS, evento 23, DOC1).

Citada (Evento 16), a parte ré apresentou contestação (Evento 16).

Referiu que cláusula contratual que, expressamente, prevê a exclusão de cobertura para medicamentos e sua aplicação em nível ambulatorial e, consequentemente, de cobertura para medicamentos de uso domiciliar. Sustentou, em suma, que o contrato firmado com a autora é anterior à vigência da Lei nº 9.656/98 e não foi adaptado, regendo-se, portanto, exclusivamente por suas cláusulas. Argumentou que o contrato, em sua cláusula 15ª, alínea "d", exclui expressamente a cobertura de "medicamentos e aplicações medicamentosas em nível ambulatorial", o que, por consequência, abrangeria o tratamento de uso domiciliar pleiteado. Alegou que a autora teve oportunidade de adaptar seu plano à nova legislação, mas optou por não o fazer, mantendo as limitações originais. Impugnou o pedido de inversão do ônus da prova e requereu a total improcedência da ação. Anexou documentos.

Houve réplica (Evento 20).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (Evento 23), a parte autora requereu prazo para juntada de novos documentos médicos (Evento 29), o que foi deferido (Evento 31). A parte ré, por sua vez, manifestou-se pela improcedência da demanda (Evento 28).

A autora juntou novos exames e um laudo médico atualizado, reiterando o pedido de tutela de urgência (Evento 35), o qual foi novamente indeferido, mantendo-se a decisão anterior (Evento 37).

Relatei. Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos relevantes para o deslinde da causa já se encontram suficientemente demonstrados pelos documentos carreados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Gize-se que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, pacificando tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 608, com o seguinte teor:

> **Súmula 608**. **Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.**

Nestas circunstâncias, o art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Igualmente, deve incidir o disposto no art.51, IV, §1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Considera-se também exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

Da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que a autora é beneficiária de um plano de saúde PECAM TI individual/familiar contratado em 01 de junho de 1987 -**evento 1, CONTR8**, portanto, em data anterior à promulgação da Lei nº9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Este fato é de suma importância para o deslinde da controvérsia, pois define o regime jurídico aplicável à relação contratual.

Assim, em se tratando de plano de saúde não regulamentado ou adaptado à Lei nº 9.656/98, devem ser respeitadas as cláusulas contratuais estipuladas.

Nesse sentido:

> APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. *PLANO* DE *SAÚDE*. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. RESSONÂNICIA MAGNÉTICA. *CONTRATO NÃO REGULAMENTADO*. **INAPLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.** COBERTURA DEVIDA. 1. AINDA QUE INAPLICÁVEL A LEI 9.656/98 AOS *CONTRATOS* DE *PLANO* DE *SAÚDE* FIRMADOS EM DATA ANTERIOR, A QUESTÃO DEVE SER APRECIADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SÚMULA 608 DO STJ), COM INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AOS ADERENTES CONFORME (ART. 47 DO CDC). 2. O *PLANO* DE *SAÚDE NÃO* PODE SE RECUSAR A CUSTEAR O EXAME PRESCRITO PELO MÉDICO, POIS CABE A ESTE DEFINIR A NECESSIDADE. ALÉM DISSO, O QUE IMPORTA É A EXISTÊNCIA DE COBERTURA DO *CONTRATO* PARA A DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. 3. NOS TERMOS DO ART. 51, IV, DO CDC, MOSTRA-SE ABUSIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI DO TRATAMENTO O FÁRMACO PLEITEADO, UMA VEZ QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA FRENTE À OPERADORA DE *PLANO* DE *SAÚDE*. 4. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 381, DO STJ. EXIGIR PEDIDO EXPRESSO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA, PORTANTO, NULA DE PLENO DIREITO, VIOLA O ARTIGO 6º, IV DO CDC, QUE ESTABELECEU COMO DIREITO BÁSICO/MÍNIMO DO CONSUMIDOR A PROTEÇÃO CONTRA QUALQUER TIPO DE ABUSO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. POR OUTRO LADO, AS NORMAS DA LEI CONSUMERISTA SÃO DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL, OU SEJA, SÃO DIREITOS QUE ULTRAPASSAM A *INDIVIDUALIDADE* DO SUJEITO. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSIDERANDO QUE FOI DADO A CAUSA O VALOR DE ALÇADA, PLENAMENTE POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, §8°, DO CPC. HONORÁRIOS DO PROFISSIONAL QUE DEVEM REMUNERAR COM DIGNIDADE O LABOR. VERBA HONORÁRIA MANTIDA NA FORMA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50082129620208210022, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 30-06-2021). [Grifei].

A controvérsia central dos autos cinge-se a aferir a legalidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear o medicamento NINTEDANIBE (OFEV) 150mg, prescrito à autora para tratamento de fibrose pulmonar secundária à Esclerodermia (CID 10: J84.1), com base na alegação de exclusão contratual por se tratar de medicamento para uso domiciliar e ambulatorial em contrato não adaptado à Lei nº 9.656/98.

Os contratos de planos de saúde celebrados antes da vigência da referida lei são classificados como "não regulamentados", e suas coberturas e exclusões são regidas, primordialmente, pelas cláusulas pactuadas entre as partes, observados os princípios gerais do direito contratual e as normas de proteção ao consumidor. A aplicação da Lei nº 9.656/98 a tais contratos não é automática, dependendo da expressa opção do consumidor pela adaptação do seu plano, conforme disposto no artigo 35 do referido diploma legal.

No caso concreto, a ré demonstrou ter ofertado à autora a possibilidade de adaptação do seu contrato ao novo regime legal, o que, contudo, foi por ela recusado - Evento 16, CONTR4, fl.19. Ao optar por manter as condições originais da avença, a autora, de forma consciente e voluntária, escolheu permanecer sob a égide do regime contratual original, com suas respectivas coberturas e limitações, presumivelmente em troca de uma contraprestação pecuniária mensal inferior àquela que seria devida em um plano adaptado. Destarte, não pode, agora, pretender valer-se das coberturas e garantias da lei que optou por não aderir, buscando extrair do contrato apenas os bônus, sem arcar com os ônus correspondentes.

Dessa forma, o contrato em questão é classificado como "não regulamentado", o que significa que as suas cláusulas e a extensão da cobertura assistencial não são regidas pelas disposições da Lei nº 9.656/98.

A relação jurídica em exame submete-se, portanto, às estipulações do instrumento contratual e aos princípios gerais do direito contratual, incluindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a ré se desincumbiu de seu ônus ao apresentar o contrato e demonstrar que o procedimento postulado não encontra cobertura na apólice da autora, por se tratar de medicamento para uso domiciliar, denominado "serviços e medicamentos não diretamente relacionados com as condições que determinaram a internação" e "medicamentos e aplicações medicamentos em nível ambulatorial", conforme consta no Caítulo VII - Dos serviços Não abrangidos - Cláusula 15ª, alíneas 'c' e 'd' - Evento 16, CONTR4, fl.4.

c. Hospitalizações para exames e procedimentos que tecnicamente possam ser realizados em regime ambulatorial, internações pré-operatórias para realização de exames; fisioterapia e radioterapia para hospitalizados, serviços de enfermagem e outros de caráter particular; despesas com acompanhantes; produtos de toalete e cosméticos, próteses e aparelhos implantados, mesmo em acidentes pessoais; despesas com os doadores em transplantes; serviços e medicamentos não diretamente relacionados com as condições que determinaram a internação; clínicas de repouso e recuperação; hospitalizações que excedam os prazos e condições contratuais; hospitalizações para doenças agudas em fase crônica irreversível e exames e procedimentos pré e pós operatórios relacionados com cirurgias sem cobertura contratual.

d. Transporte de pacientes; atendimentos domiciliares; medicamentos e aplicações medicamentosas em nível ambulatorial;odontologia e casos odontológicos; check-up e investigações diagnósticas não relacionadas com um quadro clínico estabelecido; hemodiálises; serviços não existentes na área de atuação da CONTRATADA ou que passam a sê-lo após a assinatura do contrato, exceto se expressamente previstos ou incluídos por adendo posterior.

A prescrição do medicamento NINTEDANIBE (OFEV) indica seu uso por via oral, duas vezes ao dia, para ser administrado pela própria paciente em seu domicílio, sem a necessidade de internação hospitalar ou supervisão direta e contínua de um profissional de saúde em ambiente clínico.

Tal modalidade de tratamento se enquadra perfeitamente na definição de uso domiciliar e, por sua natureza, decorre de uma prescrição para ser executada fora do ambiente hospitalar. A cláusula contratual, portanto, abrange a situação fática em análise, excluindo o dever de custeio por parte da operadora.

Não se pode reputar a referida cláusula como abusiva. O Código de Defesa do Consumidor, embora aplicável à espécie, não veda a estipulação de cláusulas limitativas de direito, desde que redigidas com destaque e de forma clara, permitindo ao consumidor a imediata e fácil compreensão de seu alcance, conforme preceitua o artigo 54, § 4º, do referido diploma.

No caso, a cláusula de exclusão está inserida em capítulo específico sobre os serviços não cobertos, com redação inteligível, não havendo que se falar em violação ao dever de informação. A validade de tais cláusulas em contratos não adaptados é reconhecida como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro da avença, que foi pactuada sob bases atuariais distintas daquelas impostas pela legislação superveniente.

Quanto à tese autoral de que o medicamento é antineoplásico, a parte autora, em suas manifestações, sustenta que o NINTEDANIBE (OFEV) seria um antineoplásico oral e, por isso, sua cobertura seria obrigatória, mesmo em contratos que excluem medicamentos de uso domiciliar. Contudo, a exceção para antineoplásicos orais deriva diretamente da Lei nº 9.656/98 e de suas alterações, que, como já exaustivamente demonstrado, não se aplicam ao contrato em tela por ser não regulamentado.

Ademais, a própria indicação do medicamento, conforme laudos médicos acostados pela autora (evento 1, LAUDO6 e evento 35, ATESTMED2), é para o tratamento de fibrose pulmonar secundária à Esclerodermia, e não para uma patologia oncológica.

A pretensão de estender uma exceção legal, aplicável a contratos regulamentados, a um contrato não regulamentado, com base em uma indicação secundária do fármaco, não encontra amparo legal ou contratual.

A liberdade de contratar permite que as partes estabeleçam os limites da cobertura, e a autora, ao optar por manter um contrato mais antigo e, presumivelmente, com contraprestações financeiras distintas das dos planos regulamentados, assumiu o risco de não contar com as coberturas ampliadas pela legislação posterior.

É certo que o direito à saúde é garantia constitucional e a dignidade da pessoa humana é um dos pilares. Contudo, a assistência à saúde suplementar é exercida em caráter complementar ao sistema público, por meio de relações contratuais de natureza privada. A imposição de coberturas não previstas em contrato, especialmente em planos não regulamentados onde o consumidor optou por manter condições mais restritivas, implicaria em desequilíbrio atuarial para a operadora e para a coletividade de beneficiários, que teriam de arcar com o aumento dos custos.

Dessa forma, a negativa de cobertura por parte da ré, ao se basear na exclusão contratual em um plano de saúde não regulamentado ou ausência de previsão no rol da ANS, para o caso específico, configura exercício regular de um direito, não havendo que se falar em ato ilícito ou abusividade. A pretensão da autora, de obrigar a demandada fornecer o medicamento para tratamento domiciliar, não encontra amparo no contrato firmado entre as partes.

Portanto, a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.

Isso posto, **JULGO IMPROCEDENTE** a presente ação proposta por **IRENE GAUER** contra **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA**, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento da taxa única e despesas processuais, bem como honorários ao procurador da parte ré, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, dada a simplicidade da ação, sem dilação instrutória. Exegese do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em relação à parte autora, na forma do art.98, §3º, do CPC, em razão de estar litigando sob o manto da gratuidade da justiça.

Havendo recurso, após processado, remetam-se ao TJRS. Caso contrário, arquivem-se.

Intimações agendadas no sistema.

Documento assinado eletronicamente por **JOAO PAULO BERNSTEIN, Juiz de Direito**, em 02/10/2025, às 18:33:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10092232757v10** e o código CRC **efdfdd31**.